

筛选号： □□□□□□□

一项评估在真实世界中阿伐替尼治疗中国胃肠间质瘤（GIST） 患者安全性和疗效的全国多中心、非干预性临床研究

研究分期： IV 期
方案号： Avapritinib-4-001

知 情 同 意 书

（第 1.0 版，2021 年 12 月 7 日）

受试者姓名： _____

研究中心名称： _____

主要研究者： _____

申办者： 申石生物医药（上海）有限公司

1. 为什么发给我这份知情同意书？

您被邀请参加名为“一项评估在真实世界中阿伐替尼治疗中国胃肠间质瘤（GIST）患者安全性和疗效的全国多中心、非干预性临床研究”的临床研究。本临床研究由申石生物医药（上海）有限公司（下文称为“申办方”）申办。本研究的主要研究药物是目前已在中国获批的 KIT 和 PDGFR α 基因突变的一种强效、选择性、小分子抑制剂——阿伐替尼。

本研究信息将会在中国临床试验注册中心的网站上公布，您可以前往该网站（www.chictr.org.cn）了解更多信息。本研究的整个过程将严格遵循中国国家法律法规及国际普遍认可的相关指导原则。

在您决定愿意参加研究之前，您需要了解为什么要开展本研究、将怎样使用您的信息、研究将涉及什么、可能的受益、风险和不适，这对您十分重要。请抽出时间仔细阅读以下信息。如果您对其中有些术语不熟悉，或对任何内容不理解，或者想要知道更多的信息，请问研究医生或其他研究人员。如果您愿意，也可以与您的家人、朋友或自己熟悉的医生讨论本研究。如果您决定参加本研究，您需要在本知情同意书的末尾签署同意声明（您将保留一份副本）。在您阅读和签署本知情同意书前不会开展任何研究程序。您可以随时退出研究并且不需要给出任何理由。拒绝参加本研究或决定退出研究，都不会对您的医疗服务产生影响。

2. 研究的背景和目的是什么？

2.1. 研究背景

胃肠道间质瘤（GIST）是胃肠道（GI）最常见的肉瘤，在所有胃肠道恶性疾病中占比约为 0.1%~3.0%。此类肿瘤多依赖于单个基因的突变。大多数 GIST 与 KIT 或 PDGFRA 这两种基因发生突变有关。接近 75%-80% 的患者 KIT 基因发生原发激活突变。此外，5%-10% 的 GIST 由 PDGFRA 突变引起，最常见的突变是外显子 18 中的 D842V 位点的突变。

目前，无论患者突变状态如何，不可切除/转移性 GIST 的治疗方案主要是依次使用靶向作用于 KIT 的酪氨酸激酶抑制剂（TKI）。然而，后续 TKI 对不同突变的

活性存在很大差别。伊马替尼是新确诊 GIST 的标准治疗。然而，它对 KIT 外显子 11 突变最有效，对外显子 9 突变的作用较弱。一些携带 PDGFRA 突变的肿瘤或野生型肿瘤对伊马替尼不敏感。

阿伐替尼获批之前，已批准的 TKI 药物均不能选择性地抑制 KIT 第 17 外显子突变或 PDGFRA D842V 突变。因此对于这些突变依赖性 GIST 的医疗需求尚未得到满足。

2.2. 研究目的

阿伐替尼（Avapritinib）是一种强效、高选择性 I 型 KIT、PDGFRA 活化环突变抑制剂。NAVIGATOR 研究是一项开放标签、非随机、剂量递增/剂量扩展的 I 期研究，在 9 个国家的 17 个中心开展，评估阿伐替尼用于不可切除或转移性 GIST 患者的安全性和疗效。2019 年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会上公布的数据显示，PDGFRA 外显子 18 突变患者的客观缓解率（ORR）达到 86%，一线治疗 ORR 达到 100%，2021 年《欧洲癌症杂志》（European Journal of Cancer, EJC）公布的 NAVIGATOR 研究结果显示，56 例 D842V 突变患者中，51 例获得缓解，ORR 为 91%，中位无进展生存期（PFS）达到 34 个月。2020 年，阿伐替尼获美国 FDA 批准用于不可切除或转移性 PDGFRA 外显子突变(包括 D842V)突变 GIST 成人患者的治疗。2021 年 3 月 31 日，中国国家药品监督管理局(NMPA)批准阿伐替尼的新药上市申请，用于治疗 PDGFRA 外显子 18 突变(包括 PDGFRA D842V 突变)不可切除或转移性 GIST 成人患者。本研究旨在观察阿伐替尼在真实世界治疗中国 GIST 患者的安全性和疗效。

3. 这是一项什么样的研究？

这是一项在真实世界中评价和收集阿伐替尼治疗 GIST 患者的安全性信息，和不同治疗方案下 GIST 患者的治疗效果的临床研究。

本研究包括 4 个队列：

队列 1：接受阿伐替尼治疗，患有 PDGFRA 基因外显子 18 突变的不可切除或转移性 GIST 患者（计划入组 100 例受试者）。

队列2：接受阿伐替尼进行围手术期（新辅助和/或辅助）治疗，有PDGFRA基因外显子18突变的GIST患者（计划入组40例受试者）。

队列3：接受阿伐替尼治疗，患有不可切除或转移性GIST，无KIT外显子13、外显子14和 PDGFRA基因外显子18突变的患者（计划入组40例受试者）。

队列4：接受非阿伐替尼的其他TKI药物治疗，患有PDGFRA基因外显子18突变的不可切除或转移性GIST患者（计划入组20例受试者）。

4. 我必须参加吗？

参加本研究是完全自愿的，您可以拒绝参加本研究。即使您拒绝参加研究，您不会遭受任何损失，包括您享有的各种医疗保健权益。如果您决定参加，您也可以改变主意，随时退出研究。您不需要解释您退出的理由。如果您退出，不会承担任何责任，也不会影响您的医疗保健权益。

如果研究医生认为退出研究会对您有利，那么他们可以在任何时间请您退出。

另外，中国国家药品监管机构或独立伦理委员会（此类委员会审查研究安全和伦理以确保受试者权利不受侵犯）可以在没有您的许可的情况下，于任何时间终止您继续参加本研究，但会事先向您解释终止的理由（如为了您自身的安全、研究药物安全性等），并且给予您后续治疗的建议（若适用）。另外，申办方有权出于医学或商业原因停止本研究。如果发生该情况，所有参加研究的受试者将退出本研究。

如果您退出（或被终止继续参加）本研究，您仍需要完成研究退出程序。

5. 研究期间我将经历什么情况？

5.1. 研究药物

队列1、2和3：阿伐替尼。

队列4：除阿伐替尼外其他TKI药物，如伊马替尼、舒尼替尼、瑞戈非尼、瑞派替尼等。

本研究为观察性研究，由您的研究医生根据临床实际情况决定您的用药方案，包括用药剂量和用药周期。

本研究所有使用的药物都是已经在中国获批上市的药物。研究药物的药品信息可参考药品说明书。

5.2. 研究流程

本研究为非干预性研究，您的诊断和治疗方案由您的研究医生按照临床实际情况做出临床决策。本研究仅对方案规定的临床数据进行收集和分析。

如果入选本项研究，预计您参加研究的最长持续时间约为 36 个月。完成所有研究治疗或者停止治疗之后，可能需要您配合继续进行后续的随访访视数据收集，以监测您接受研究治疗后可能会出现副作用或者获益。

您需阅读本知情同意书，如果您充分了解本文件的内容，并且自愿参加本项研究，您需要签署本文件。在您签署知情同意书后，您的以下数据将被收集：

5.2.1. 基线期

按照临床诊疗常规，在开始治疗之前您的研究医生会为您安排必要的检查，以明确您的病情，并指导后续的治疗方案。本研究需要收集的治疗前数据包括：

- 人口统计学资料：性别、出生日期/年龄、种族和族裔；
- 病史：记录合并疾病和伴随疾病，包括 GIST 和其他恶性肿瘤病史、共存疾病；
- 体格检查：完整的体格检查和基本的神经学评估；
- 生命体征：体重、身高、体温、脉搏和收缩压/舒张压；
- 常规临床检验和实验室检查：包括血常规、尿常规、肝功能、血生化、凝血功能、血清妊娠试验（仅针对有生育能力女性）；
- 病理学检查：药物治疗前筛选访视期的原发灶发生部位、病灶大小（可评估病灶）、组织学类型、核分裂象计数、肿瘤性浸润、研究病理分期、淋巴结转移个数、远端转移部位。
- 免疫组织化学：肿瘤细胞 CD117、DOG-1、Ki67、SDHB（胃来源）；
- 基因学检查：KIT 和 PDGFRA 的突变类型。
- 心电图检查：12 导联心电图；

- 影像学检查：根据医生决定的诊断技术（如腹部及盆腔计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）检查等）进行的肿瘤评估；
- 东部肿瘤协作组（ECOG）体力状况（PS）评分；
- 既往治疗情况：既往 GIST 治疗（TKI 治疗药物和次数、既往手术次数和类型）、对每例治疗的缓解（如有）、是否进行辅助治疗等；
- 伴随用药。

5.2.2. 治疗期

在治疗期间，需要您积极配合各项检查及治疗，您的研究医生会依据临床诊疗常规和您的临床实际情况定期对您进行各种临床检查，包括肿瘤的影像学检测评估，以评价您接受研究药物治疗后的安全性和疗效。因此在来院访视时，请主动告诉研究医生您所有的身体不适，包括出现与持续的时间、症状以及是否在外院就诊或吃过什么药物等，医生也将通过各项检查与问诊了解您的身体情况。每次访视后，医生都会告知您是否需要继续用药，请您务必遵循医生的指导。您需要每天在日志卡上记录服用药物的情况，除此以外，如您有不适或其他的用药物情况，也需要记录在日志卡上。

在此期间内，本研究需要收集的数据包括：

- 安全性数据：所有不良反应的类型、频率、出现时间、恢复时间、严重程度分级、与研究药物的关系、处理方案和结局；
- 疗效数据：您的研究医生判定的疗效结果；
- 用药数据：您记录在日志卡上的药物剂量、使用时间和其他的用药情况。

5.2.2.1. 疾病进展后继续治疗

您在研究期间接受治疗时，您的研究医生可能会发现您的肿瘤再次开始变大，这称为疾病进展。您的研究医生可能会决定停止研究治疗。如果您感觉好转，且您的研究医生认为您正在从研究治疗中获益，尽管肿瘤看起来变得更大，只要您和您的研究医生认为这符合您的最佳利益，您仍可以选择继续接受研究治疗。

- 无预示临床疾病进展的症状和体征，无预示疾病进展的实验室检查指标的恶化；
- 稳定的 ECOG PS $\leq$ 1；
- 在重要解剖学部位没有出现需要其它紧急医学干预的快速疾病进展或肿瘤增大（如脊髓压迫）；

您将持续接受研究治疗，直至您自己或您的研究医生认为您无法从持续治疗中获益。

5.2.2.2. 治疗结束

在治疗终止或治疗期结束时，本研究需要收集的数据包括：

- 安全性数据：所有不良反应的类型、频率、出现时间、恢复时间、严重程度分级、与研究药物的关系、处理方案和结局；
- 疗效数据：您的研究医生判定的疗效结果；
- 用药数据：您记录在日志卡上的药物剂量、使用时间和其他的用药情况。
- 如果您在接受研究药物治疗期间出现进展，并通过基因检测发现耐药突变，本研究将收集耐药突变数据。

5.2.3. 随访期

在您结束研究药物治疗后，本研究将继续进行后续的随访期数据收集，以监测您接受研究治疗后可能会出现副作用或者获益。需要收集的数据包括：

- 安全性数据：通常在最后一次用药后 30 天，通过电话进行。将询问您是否已经开始其他抗肿瘤治疗，并询问您是否注意到任何健康状况方面的变化或有任何不适。
- PFS（疗效）数据：通常在安全性数据收集后每 3 个月一次，直至疾病进展、失访、开始新的抗肿瘤治疗、死亡、撤回知情同意书或申办方终止研究。将收集您的研究医生判定的疗效。
- 生存随访：通常每 3 个月一次，通过电话进行。将询问您的健康状况。

5.3. 研究停止

一般来说，您可以参加本研究直至出现下列情况（包括但不限于）：

- 您决定不再继续参加研究
- 您未完成要求进行的程序
- 您已妊娠或决定妊娠
- 您的疾病加重
- 您因接受研究药物而发生无法接受的副作用
- 您在参加研究期间，接受禁止使用的其他治疗
- 研究者认为您不再能够继续得到临床获益
- 您的研究医生认为继续接受研究治疗不是最佳选择
- 您的研究医生接收到了关于研究药物安全性或有效性的新的重要信息
- 申办方可以在不经过您同意的情况下决定终止研究

您可以随时决定退出研究。如果您考虑或决定中止接受研究药物治疗，请务必及时告知研究医生。因为告知医生您正在考虑中止参加研究，可以讨论何种随访治疗和检查对您帮助最大。

6. 我在研究期间必须做些什么？

如果您签署知情同意书选择参加本研究，在研究期间您应该：

- 请您按研究医生和您约定的随访时间来医院就诊。您的及时接受随访非常重要，因为医生将判断您接受的治疗是否真正起作用。
- 请您按照您研究医生的医嘱用药。
- 请您按照您的研究医生的嘱托，将用药和身体不适的情况记录在日记卡中。
- 每次来医院就诊时，请您携带日记卡，并及时向研究医生说明药物漏服、多服或者其他特殊情况。
- 在研究期间中，研究医生将询问您目前正在使用的药物和治疗情况，与您讨论可能的副作用。请您描述您的感觉。

- 如您有其它合并疾病须继续服用相应的药物，或者您正在使用任何“非处方药”、草药和天然疗法，请及时告知您的研究医生。
- 如果您同时接受其他抗肿瘤治疗，如同步放疗或癌症相关的手术等，请及时告知您的研究医生。
- 如果您在其他医生处就诊或住院治疗，请您及时告知您的研究医生。
- 如果您认为您出现怀孕或伴侣出现怀孕，请您及时告知您的研究医生。
- 在您参加本研究期间不可参加任何其他的注册临床研究。如果您准备参加另一项临床研究，您一定要让负责那项研究的医生知道，您正在参加本研究。您应该请那位医生与您的研究医生联系，讨论其它的必要治疗措施。
- 您需要把在本研究进行期间准备接受的所有医学治疗告诉您的研究医生（例如择期手术或者放疗）。如果您不确定能否接受某种治疗，请您及时向您的研究医生寻求指导。
- 在研究期间和研究药物末次给药后 120 天内，严格避孕。
- 除了您本人之外，希望您家属成员中至少有一位能够了解您将参与的临床研究并能关心您的病情，同时在后续随访中能够向研究医生反馈您的健康状况。您的家属应在您发生严重不适时（包括需住院进行治疗）时及时通知您的研究医生。
- 如果您的地址、电话号码或者其他联系信息发生了变化，请告诉您的研究医生。

7. 使用其他药物

有些药物在研究期间禁止使用，有些药物应避免使用。您的研究医生会与您讨论此问题。如果您不确定是否正在服用任何这些药物，或者您不确定药物名称，请咨询您的研究医生。

8. 可能的风险有哪些？

任何临床研究都有一定的风险，您可能接受的是对您无效或疗效有限的治疗，您的情况可能恶化或者没有改进。任何研究药物都有可能会出现其他不可预见的甚

至是严重的副作用。如果您在治疗期间有任何不适，一定要及时通知您的研究医生，他/她将对做出判断和医疗处理。

在参加整个研究期间可能会出现的副作用及风险包括但不限于下列各项：

8.1. 已知研究药物副作用

在研究期间，您可能会因服用研究药物和研究程序产生不适和风险。不适和风险可能因人而异。我们将密切观察每个研究参与者是否发生副作用（不良反应）。

如果出现任何不适或风险，您必须立即告知您的研究医生。

您的医生可能会给您用药以帮助减轻一些不适和风险。如果您使用研究药物后出现严重反应，您的医生可能会暂停或减少研究药物剂量或终止研究治疗。

8.1.1. 阿伐替尼

根据阿伐替尼药品说明书，不良反应发生频率定义为：十分常见（ $\geq 1/10$ ）；常见（ $\geq 1/100$ 至 $< 1/10$ ），偶见（ $\geq 1/1000$ 至 $< 1/100$ ），罕见（ $\geq 1/10000$ 至 $< 1/1000$ ），十分罕见（ $< 1/10000$ ）。临床试验中接受阿伐替尼治疗的不良反应如表 1 所示：

表 1 临床试验中接受阿伐替尼治疗的不良反应

系统器官分类/ 频率分类	不良反应	所有级别 %	≥ 3 级 %
全身性疾病及给药部位各种反应			
十分常见	水肿 ¹	70.2	4.7
	疲乏 ²	45.1	6.5
	干燥 ³	10.9	0.2
常见	感到寒冷	2.9	—
	不适	2.5	0.2
	发热	1.8	0.2
感染及侵染类疾病			
常见	结膜炎	2.0	—
血液及淋巴系统疾病			
十分常见	贫血	39.6	20.4
	中性粒细胞计数降低	15.8	8.9
	白细胞计数降低	14.0	3.1
常见	血小板减少症	8.4	0.9
	淋巴细胞计数降低	4.7	2.2
呼吸系统、胸及纵隔疾病			
	胸腔积液	6.0	0.9

常见	呼吸困难	6.0	0.7
	咳嗽	2.2	—
	鼻充血	1.5	—
胃肠系统疾病			
十分常见	恶心	45.1	1.5
	腹泻	26.4	2.7
	呕吐	24.2	0.7
	胃食管反流病	12.9	0.5
	腹痛	10.9	1.1
常见	腹水	7.5	1.3
	便秘	5.8	—
	吞咽困难	2.4	0.4
	口腔黏膜炎	2.4	—
	胃肠出血 ⁴	2.2	1.6
	肠胃气胀	1.6	—
	唾液分泌过多	1.5	—
神经系统疾病			
十分常见	记忆受损	22.7	0.9
	味觉影响	12.7	—
	认知障碍	11.8	0.9
	头晕	10.5	0.2
常见	周围神经病变	8.5	0.4
	头痛	8.0	0.2
	精神损害 ⁵	5.6	0.7
	言语障碍	4.5	—
	震颤	2.2	0.2
	嗜睡	1.8	—
	失语	1.8	—
	颅内出血 ⁶	1.6	1.1
	平衡障碍	1.6	—
	运动机能减退	1.3	0.2
偶见	脑病	0.9	0.5
代谢及营养类疾病			
十分常见	食欲下降	21.1	0.5
常见	低磷酸血症	8.9	2.5
	低钾血症	6.0	0.9
	低镁血症	3.8	0.4
	低白蛋白血症	2.4	—
	低钙血症	2.2	0.4
	脱水	1.8	0.5
	低钠血症	1.3	0.7
心脏器官疾病			
偶见	心包积液	0.9	0.2
血管与淋巴管类疾病			
常见	高血压	3.3	1.1
良性、恶性及性质不明的肿瘤（包括囊状和息肉状）			
偶见	肿瘤出血	0.2	0.2
精神疾病			
	意识模糊状态	4.7	0.5

常见	抑郁 失眠 焦虑	4.2 3.8 1.8	0.4 - -
眼器官疾病			
十分常见	流泪增加	22.2	-
常见	视物模糊	2.9	-
	结膜出血	2.4	-
	畏光	1.6	-
	眼部出血 ⁷	1.1	-
耳及迷路类疾病			
常见	眩晕	2.4	-
肝胆系统疾病			
十分常见	高胆红素血症	27.5	5.8
偶见	肝出血	0.2	0.2
皮肤及皮下组织类疾病			
十分常见	毛发颜色改变	15.3	0.2
	皮疹	12.7	1.6
常见	脱发	9.6	-
	瘙痒症	2.9	-
	掌跖红肿综合征	1.3	-
	光敏性反应	1.1	-
	皮肤色素减退	1.1	-
各种肌肉骨骼及结缔组织疾病			
常见	肌痛	2.0	-
	关节痛	1.8	-
	肌痉挛	1.6	-
	背痛	1.1	-
肾脏及泌尿系统疾病			
常见	血肌酐升高	4.4	-
	急性肾损伤	2.0	0.9
	血尿症	1.1	-
各类检查			
十分常见	转氨酶升高	12.4	0.9
常见	体重降低	7.5	0.2
	体重增加	4.7	-
	血肌酸磷酸激酶升高	3.3	0.4
	心电图 QT 间期延长	2.0	0.2
	血乳酸脱氢酶升高	1.3	-

¹ 水肿（包括眶周水肿、外周水肿、面部水肿、眼睑水肿、液体潴留、全身性水肿、眼眶水肿、眼睛水肿、水肿、外周肿胀、面肿、眼肿、结膜水肿、喉水肿、局部水肿、唇肿胀）

² 疲乏（包括疲乏、乏力）

³ 干燥（包括唇部干燥、口干、干眼、皮肤干燥）

⁴ 胃肠出血（包括胃出血、胃肠出血、上消化道出血、直肠出血、黑便）

⁵ 精神损害（包括注意障碍、精神损害、精神状态改变、痴呆）

⁶ 颅内出血（包括大脑出血、颅内出血、硬膜下血肿、大脑血肿）

⁷ 眼部出血（包括眼出血、视网膜出血、玻璃体出血）

-：未报告≥3 级不良反应

8.1.2. 其他 TKI 药物

已上市的治疗 GIST 常用 TKI 药物包括伊马替尼、舒尼替尼、瑞戈非尼、瑞派替尼等，其常见不良反应可参考药品说明书。

如果在研究中您出现任何不适，或病情发生新的变化，或任何意外情况，不管是否与药物有关，均应及时通知您的研究医生，他/她将对此做出判断和医疗处理。

8.2. 是否存在生殖风险

- 已经妊娠或计划妊娠的女性，不得参加本研究。要求有生育能力的女性接受妊娠试验以排除妊娠。有生育能力的女性在参加研究期间，必需采取有效的避孕措施。在参加研究期间如发现自己妊娠，应立即告知研究医生。
- 如果您是一名有生育能力的女性，或者如果您是有生育能力女性伴侣的男性，您和您的伴侣必需愿意在参加研究期间以及研究用药结束后 120 天内，使用符合当地可接受标准的高度有效的避孕措施（除屏障方法外）。您的研究医生或护士将为您提供避孕相关信息。如果您是一名女性，您不得在参加本研究期间以及末次研究药物给药后 120 天内捐献卵细胞或卵子。如果您是一名男性，您不得在参加本研究期间以及末次研究药物给药后 120 天内捐献精子。
- 如果您的避孕方法发生了变化或您开始使用的任何处方药物或其他药物并非由研究医生提供，您应当立即联系研究医生。
- 如果您或您的伴侣妊娠，您必需立即告知研究医生，因为这可能会对胎儿构成风险。在参加本研究期间，如果某男性受试者的女性伴侣妊娠，则应立即告知研究医生。如果某男性受试者的女性伴侣妊娠，则会要求该男性受试者提供关于其女性伴侣妊娠结局的相关信息（如相关信息已知）。在这种情况下，数据采集前，还需要该男性受试者的女性伴侣提供知情同意。
- 如果研究期间妊娠，则会被剔除本研究。

9. 有哪些可能利益？

我们希望本研究药物将使您的病情有所改善，但您也可能不会从参加本研究中受益。本项临床研究的结果可能加深您对所患疾病的医学科学知识的了解，也可能

在将来对和您患有相同疾病的患者的治疗带来益处。您可能通过研究中进行的体检和医学检查得到与您健康相关的信息。

10. 是否有替代治疗？

您是完全自愿参加本临床研究。参加研究不是进行治疗的唯一选择。如果您不参加本临床研究，您的医生会根据您实际的身体状况向您推荐合适的治疗方法，可能的治疗选择：

- 临床指南推荐的治疗；
- 其他临床研究；
- 其他医生认为合适的治疗方法

11. 我会由此产生任何费用或收到任何报酬吗？

本研究开展期间，需要您接受某些常规医学检查或程序。这些检查或程序均为您常规医疗护理的组成部分。即使您未参加本研究，也需实施这些检查或程序，因此研究期间所有检查费用将由您自己承担。

您不会因为参加本临床研究获得报酬。由于您按照要求参加临床研究访视，将产生相关的交通费，为此我们将为您提供每次访视 200 元人民币的交通补贴。补偿金将根据研究中心对付款程序的要求进行支付。如果您中途退出研究，我们会根据您的实际完成试验的情况，给予相应的交通补贴。

12. 如果我在研究中受到损伤怎么办？

申办方已经为参加本研究的受试者购买了保险。在您参加本项研究期间，如您受到了伤害，您应及时和您所在研究医院的研究医生取得联系，您的研究医生将对您进行积极治疗。经研究医生判断，如确因研究药物或研究过程引起，申办方将承担相应的医疗费用及相关法律法规规定的经济补偿。

申办方承担上述费用的前提是，您已遵守研究医生的指示。

13. 如果出现任何新信息会怎样？

如果有任何该药物研究的新信息出现，且该信息可能影响您继续参加研究的意愿，研究医生会及时地通知您。

14. 是否对与我相关的信息保密？

通过签署本知情同意书，您同意研究医生和相关的研究人员收集您的个人信息并将其用于研究。包括：您的出生日期、您的性别、您的民族以及您身体或精神健康相关的个人数据。

这些与申办方分享的信息将通过使用分配给您的特定的号码（编号）来进行保护。研究医生会管理将您与您的数据相联系的编号。

将按照法律要求为所有能通过姓名识别您的医疗记录以及研究材料保密。当然，研究医生、申办方及其代表、研究监查人员（检查研究的进展程度及确保信息的正确收集）、在某些情况下管理机构和伦理委员会，可以查看您的机密数据，该数据通过您的姓名识别。

通过签署本知情同意书，您准许管理机构的授权代表和其他政府机构获取在研究中得到的关于您的医学信息。您同时也准许申办方、研究监查人员、其他研究人员和伦理委员会获得您的医学信息。所有传送的数据将使用代码。研究医生、管理机构和申办方可能无限期保留研究记录。

您有权要求获得研究医生和申办方所保存的与您研究相关的信息。您也有权要求更正此类数据的任何不准确之处。如果您有此类要求，则请联系研究医生，如有必要他/她可以帮助您联系申办方。

您同意对上文提到的在本研究获得的您的数据的使用没有截止日期。如果您要求退出研究，在您退出研究前所获得的关于您的研究数据可能还是会被使用。一旦您要求退出研究，将不再收集任何您的数据。如果您同意可以收集您退出研究后的数据，那么这些数据将如上文描述进行使用。

本研究的结果可能在医学杂志发表，并且在医学会议展示。在任何此类出版物中，您不会被识别出（通过姓名或其他方式，如照片）。

15. 可以自愿选择参加研究和中途退出研究

是否参加研究完全取决于您的自愿。您可以拒绝参加此项研究，或在研究过程中的任何时间停止使用药物、或退出本研究，这些都不会影响您和医生之间的关系，也不会造成您的医疗或其他方面利益的损失，您将会享受同等的医疗权益。

重要的是，如果您决定停止使用任何本研究药物，请一定提前告知您的研究医生，因为在某些情况下，突然停药可能对您的身体有一定的影响。在您表达了退出意愿后，您的医生也会跟您做解释和沟通。

如果您决定退出本研究，在您退出本研究前参与本研究所获得的信息，包括但不限于数据、样本等，依然会根据科学的目的被使用和分析，该结果会被分享来确保研究的完成和数据的真实。但您的个人信息，例如名字、生日、身份证等，不会被泄露。

以下三种不同情况时，研究医生会跟您仔细讨论：

- 停止使用药物，但您依然参与研究或即使拒绝后期随访，愿意继续被您的研究医生联系；

如果您停止使用药物但依然参与本研究，同意参与本研究随访或拒绝后期随访，您的研究医生会定期与您沟通，讨论您的身体状况。同时，在得到您的同意下，您的医疗信息会被收集，这是本研究中非常重要信息，是对于后期项目的科研探讨和更加有效制定策略的重要步骤。当然，您可以拒绝研究医生的联系，您的决定不影响您将来的治疗。

- 停止使用药物并且撤回知情同意书，不再参与本研究，不愿意被您的研究医生联系；

如果您决定停止参与本研究，在研究中退出前，您可能被询问有关您使用试验药物的情况。如果医生认为需要，您也可能被要求进行实验室检查（包括影像学检查）和体格检查。这对于您的安全和受益很重要。在本次检查结束后，您的信息将不再被收集。

• 在以下情况下，您的研究医生出于对您的最大利益考虑，可能会随时终止您参加本研究，并告知您原因：

- 1) 继续参加研究可能会给您带来伤害，包括您的疾病进展和不能耐受的不良反应。
- 2) 您需要其他额外的治疗，但此治疗是本研究所禁用的。
- 3) 您未能遵从研究的要求或研究医生的治疗。
- 4) 您在治疗期间怀孕。
- 5) 本研究被国家药品监管部门暂停或终止。
- 6) 研究者或伦理委员会出于任何安全性或其他特殊考虑而终止研究。

16. 如果我有疑问怎么办？

如果您关于本研究还有疑问，或患研究相关疾病或发生研究相关损伤时，请与研究医生_____联系，联系电话_____

本项研究的方案由医学伦理委员会审查通过。如果您对作为研究受试者权益有任何疑问，请与伦理委员会_____联系，联系电话_____

是否参加本研究由您自己决定。您可以和您的家人或者朋友讨论后再做出决定。在您做出参加研究的决定前，请尽可能向您的医生询问有关问题，直至您对本知情同意书的内容完全理解。

感谢您阅读以上材料。如果您决定参加本研究，请告诉您的医生，他/她会为您安排一切参加本研究的相关事务。

17. 受试者同意声明

我已被告知以上研究信息，并已阅读所附书面信息。我已获得讨论研究和提出疑问的机会。

我了解我可以随时自由退出。我了解如果我选择不参加或退出，我当前的医疗保健不会因此决定受到影响。

我同意可以通知我的主治医生我参加了本项研究。

我同意可以按照本知情同意书所述使用我的个人数据，包括我的身体和精神健康或状况相关的数据以及民族。的数据传输将严格遵守中国法律和法规，包括但不限于《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》。

我了解我将收到并可以保存一份已签署姓名和日期的本知情同意书副本。

最后，我决定同意参加本项研究，并尽量遵从医嘱。

_____	_____	_____
受试者签名	日期（年/月/日）	受试者姓名（印刷体）

_____	_____	_____
法定代理人签名	日期（年/月/日）	法定代理人姓名（印刷体）

法定代理人受试者关系：_____

_____	_____	_____
见证人签名	日期（年/月/日）	见证人姓名（印刷体）

（如果受试者无行为能力，则需要获得法定代理人同意；如果受试者不识字，则需要见证人签名。）

18. 执行知情同意人员声明

我，作为下表签字人，已尽我所知对本研究进行充分和详细的解释，保证签署本知情同意书的受试者清楚理解参加本研究的性质、风险和利益。我确认受试者没有被强迫签署同意书，而是自由自愿地签署了同意书。我确认受试者已经获得一份此知情同意书的副本。

研究者签名（执行知情同意
人员）

日期（年/月/日）

执行知情同意人员姓名
（印刷体）